

Заболеваемость населения г. Алматы злокачественными новообразованиями

Кайдарова Д.Р.

ГККП Городской онкологический диспансер, Алматы, Казахстан.

Борьба против рака в большинстве стран мира стала неотъемлемой составной частью Программ здравоохранения. Она включает комплекс мероприятий, построенных на основе достижений современной медицинской науки в области профилактики, выявления, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных. Постоянный рост заболеваемости злокачественными опухолями, высокая смертность, а также омоложение контингента онкологических больных привели к тому, что проблема лечения рака из медицинской переросла в социально-экономическую.

Противораковая борьба является одним из приоритетных направлений современной медицины. По словам министра здравоохранения РК С.Каирбековой «необходимо сконцентрировать свою работу на профилактическом направлении, на широком внедрении скрининговых программ для своевременного выявления онкологических заболеваний» (Астана, октябрь 2011 г).

В г.Алматы в структуре общей онкологической заболеваемости последние 10 лет лидирует рак молочной железы - 14,2% (2009 - 14,2%), в 1,5 раза превышая среднереспубликанские показатели.

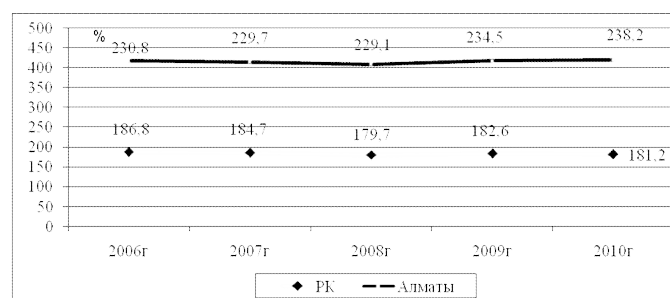


Диаграмма 1. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями г.Алматы за период 2006-2010гг.

Второе место занимает рак кожи-14,3% (2009 - 13,2%), далее рак легких -8,3% (2009 - 8,9%), рак желудка -7,9% (2009 - 7,8%), рак ободочной кишки - 5,7% (2009 - 5,1%). Данные локализации злокачественных новообразований занимают 45% всех регистрируемых случаев по г. Алматы.

В структуре заболеваемости среди мужского и женского населения стабильно высокими остаются рак легкого у мужчин (15,9%) и рак молочной железы у женщин (23,9%).

Важнейшим направлением противораковой борьбы является своевременное выявление и лечение предопухолевых процессов и раковых заболеваний на ранних стадиях. Диагностика ранних форм злокачественных новообразований предопределяет прогноз заболевания.

Число больных с впервые установленным диагнозом злокачественных опухолей, выявленных с I – II стадией стабильно повышается. Удельный вес больных с IV стадией в г.Алматы ниже среднереспубликанских значений – 9% (РК – 15,9%).

Анализ запущенности визуально доступных локализаций показал снижение удельного веса запущенных форм рака прямой кишки, шейки матки, полости рта. Тревожным фактом является повышение показателя запущенных форм рака молочной железы.

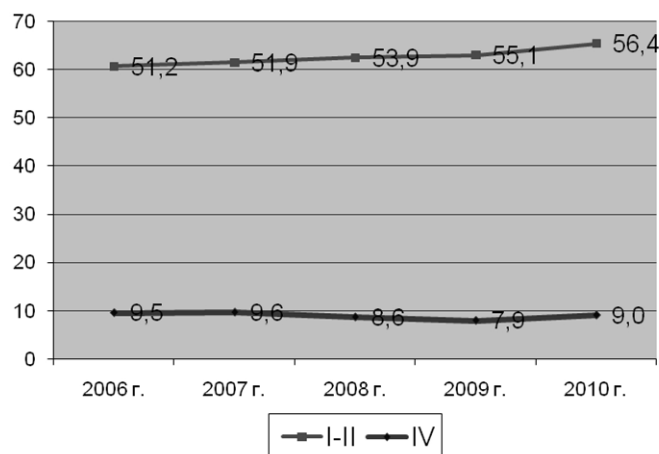


Диаграмма 2. Распределение впервые выявленных больных по стадиям в г.Алматы

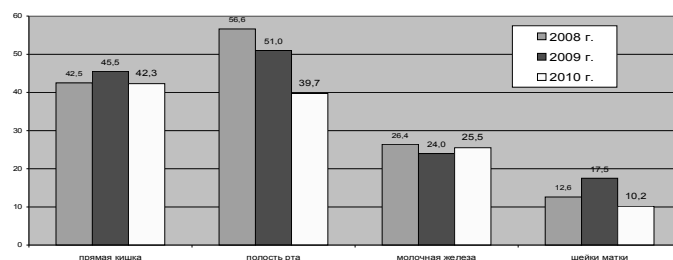


Диаграмма 3. Распределение запущенности основных визуальных форм злокачественных новообразований в 2008-2010 гг.

Одним из основных показателей в онкологии является смертность больных от злокачественных заболеваний. Этот показатель, несмотря на постоянное усовершенствование методов диагностики и лечения рака, продолжает оставаться высоким, составив в 2010 году 123,1 смертей на 100 000 населения г.Алматы, превысив среднереспубликанские показатели – 103,9.

Согласно статистическому анализу, рак легких является лидирующей онкопатологией в структуре смертности (17,0 на 100 тыс.нас.), отмечается повышение смертности от рака молочной железы, желудка, колоректального рака.

Важным показателем эффективности работы онкослужбы является 5-летняя выживаемость. Отмечается увеличение этого показателя с 43,3% в 2006 г. до 51,4% в 2010г., что достигнуто путем улучшения ранней диагностики и повышения качества лечения онкобольных.

Учитывая многогранность проблемы своевременной диагностики рака шейки матки, охватывающей медицинские, социальные и экономические аспекты, Министерством Здравоохранения РК была разработана Программа по скринингу рака шейки матки и молочной железы. С 2011 года внедрена программа скрининга колоректального рака.

В соответствии с планом мероприятий по реализации «Государственной программы реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 гг.» предусмотрено проведение профосмотров с последующим динамическим наблю-

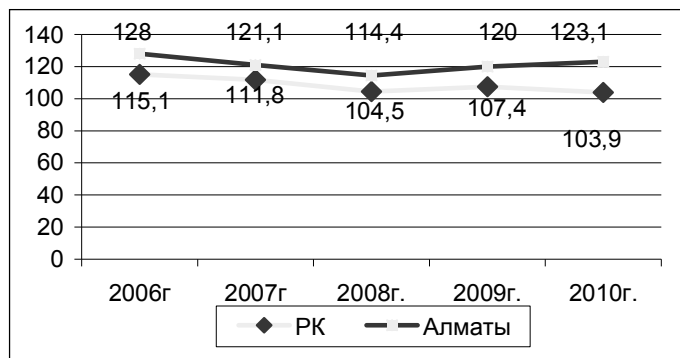


Диаграмма 4. Смертность от злокачественных новообразований в г.Алматы за 2006-2010 гг.

дением и оздоровлением женщин репродуктивного возраста, согласно приказу МЗ РК №607 от 15.10.2007 г. «О совершенствовании профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения». По г. Алматы в 2010 г. проведено 143263 цитологических исследования, из них 53525 среди женщин декретированного возраста. При этом декретированного возраста выявлено женщин с заболеваниями шейки матки – 146 случаев, в том числе 83 РШМ и 63 тяжелые дисплазии. Женщин декретированного возраста – 46, из них in situ – 5 женщин; 1 стадия – 9 женщин; 2 стадия – 4 женщины. Чувствительность цитологического исследования является важным фактором эффективности скрининга. По данным различных исследователей, показатель составляет от 66 до 83%. Плохой забор материала для цитологического исследования является причиной ложноотрицательных случаев в 70-90% случаев.

Согласно программе маммографического скрининга по г. Алматы за 2010 г. проведено 43688 маммографических осмотров. Выявлено женщин с заболеванием молочной железы – 72 случая декретированного возраста, из них: I стадия – 10, II стадия – 48 пациенток. К сожалению, выявляемость ранних форм рака молочной железы у женщин, подвергнутых скринингу, остается довольно низкой. Тем не менее, опыт стран с развитыми скрининговыми программами показывает, что требуется

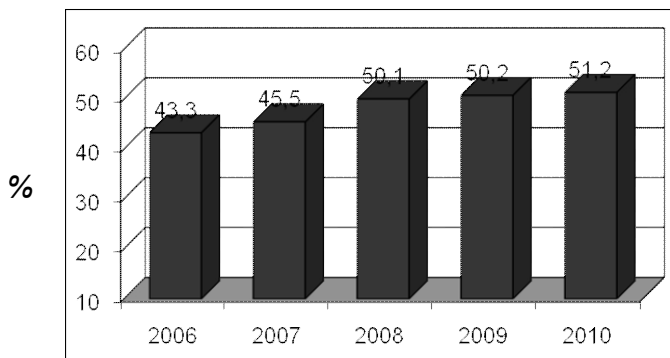


Диаграмма 5. Пятилетняя выживаемость за 2006-2010 гг.

не менее 20 лет для полноценной реализации масштабного скрининга. С целью повышения выявляемости рака молочной железы с 2011 года в Городском онкологическом диспансере внедрена вторая читка маммограмм.

По словам министра здравоохранения РК С. Каирбековой «в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» с целью снижения смертности от онкологической патологии, Минздрав подготовил и принял ряд важных нормативных документов по онкологической службе. Утверждено положение о деятельности организаций, которые оказывают онкологическую помощь. В стадии доработки находится концепция совершенствования онкологической службы до 2015 года. Она включает развитие ядерной медицины, вносятся изменения в систему финансирования онкослужбы».

Таким образом, проблема онкологии многогранна, она включает медицинский, научный, экономический, социальный аспекты в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации пациентов. В сложившейся ситуации успех борьбы с опухолевыми заболеваниями определяется наличием и возможностью реализации научно обоснованной национальной противораковой программы, направленной на снижение заболеваемости, смертности и повышение продолжительности жизни больных.